

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE SEVERIDAD DE LA FATIGA (FSS)

Fatigue Severity Scale (Krupp et al., 1989) · Validación en Español (Duarte et al., 2019; Bulbena et al., 2000)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Severidad de la Fatiga (Fatigue Severity Scale, FSS)
Sigla / Acrónimo	FSS (EGF en algunas publicaciones castellanas)
Autoría original	Lauren B. Krupp, Nicholas G. LaRocca, J. Muir-Nash, A. D. Steinberg (1989)
Adaptación en español	Duarte, Velasco, Sánchez-Sosa et al. (2019, Educ Med); Bulbena et al. (2000)
Constructo evaluado	Severidad del síntoma de fatiga y su interferencia en las actividades físicas, sociales y cotidianas
Población diana	Adultos con esclerosis múltiple, lupus eritematoso, COVID persistente, fibromialgia o depresión
Tiempo de aplicación	2 a 4 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	9 ítems calificados en una escala ordinal tipo Likert de 7 puntos (1 = desacuerdo, 7 = acuerdo total)
Condiciones de uso	Dominio público para uso clínico, docente y de investigación no comercial citando la fuente

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La fatiga es uno de los síntomas más discapacitantes y ubicuos de la medicina interna, la neurología y la psiquiatría. Se define fisiopatológicamente como una sensación abrumadora y persistente de agotamiento psicofísico que no se alivia adecuadamente con el reposo ordinario ni guarda proporción con el nivel de esfuerzo ejecutado. A nivel neurobiológico, la fatiga central involucra disfunciones en los circuitos córtico-estriado-tálamo-corticales y una sobreactivación de citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-alfa).

Krupp y su equipo en la Universidad de Stony Brook y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) crearon la FSS para diferenciar la astenia ordinaria o la fatiga transitoria del agotamiento patológico grave en enfermedades neuroinmunológicas (como la esclerosis múltiple y el lupus). La FSS no evalúa la somnolencia (deseo de dormir) ni la debilidad neuromuscular focal pura, sino el impacto global de la fatiga en la motivación, el ejercicio físico, las responsabilidades laborales y los roles familiares.

3. CONTENIDO DE LOS 9 ÍTEMS DE LA ESCALA FSS

Ítem	Contenido del Ítem (Última Semana)	Escala	Dimensión Funcional
1	Mi motivación es menor cuando estoy fatigado/a	1 a 7	Impacto motivacional y conativo
2	El ejercicio me provoca fatiga	1 a 7	Fatigabilidad física ante el esfuerzo
3	Me fatigo con facilidad	1 a 7	Umbral de agotamiento basal disminuido
4	La fatiga interfiere con mi funcionamiento físico	1 a 7	Interferencia en motricidad y marcha
5	La fatiga me causa problemas frecuentes	1 a 7	Frecuencia de afectación cotidiana
6	La fatiga me impide un esfuerzo físico mantenido	1 a 7	Resistencia muscular y capacidad de trabajo
7	La fatiga interfiere al cumplir ciertos deberes	1 a 7	Interferencia laboral y responsabilidades
8	La fatiga es uno de mis 3 síntomas más invalidantes	1 a 7	Prioridad y jerarquía sintomática
9	La fatiga interfiere con mi trabajo, familia o vida	1 a 7	Discapacidad psicosocial global

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN HISPANOPARLANTE

Consistencia interna	Excelente fiabilidad; alfa de Cronbach $\alpha = 0.88 - 0.94$ en la validación hispana de Duarte et al. (2019) y $\alpha = 0.89$ en esclerosis múltiple (Krupp et al.).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 2-4 semanas con CCI = $0.84 - 0.90$, reflejando una excelente estabilidad en sujetos estables sin brotes activos.
Validez de constructo	Estructura unidimensional robusta confirmada por análisis factorial confirmatorio; correlaciona intensamente con la Escala de Impacto de Fatiga (FIS, $r = 0.76$).
Sensibilidad y especificidad	Punto de corte promedio ≥ 4.0 : sensibilidad del 90% y especificidad del 86% para discriminar fatiga clínica severa frente a controles sanos.
Sensibilidad al cambio	Capaz de registrar mejorías significativas tras rehabilitación aeróbica adaptada, terapia ocupacional o tratamiento farmacológico específico con modafinilo o amantadina.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal	El paciente califica el impacto de la fatiga experimentado a lo largo de los últimos 7 días .
Escala de puntuación	Cada ítem se puntúa de 1 a 7 (1 = Completamente en desacuerdo ; 7 = Completamente de acuerdo).
Puntuación media estándar	La métrica canónica más utilizada es la puntuación media: " FSS Media " = (Suma de los 9 ítems) / 9. Rango: 1.0 a 7.0 puntos .
Puntuación total sumatoria	Alternativamente, en algunos ensayos clínicos se utiliza la suma aritmética directa de los 9 ítems. Rango teórico: 9 a 63 puntos .

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Media FSS (1-7)	Puntaje Total	Estrato de Fatiga	Significación Clínica y Diagnóstica
1.0 - 3.9	9 - 35	Fatiga Normal / No Clínica	Rango fisiológico habitual en sujetos sanos de la comunidad.
4.0 - 4.9	36 - 44	Fatiga Moderada / Umbral	Fatiga clínicamente relevante; interfiere en tareas exigentes.
5.0 - 5.9	45 - 53	Fatiga Severa Patológica	Típico de EM activa, síndrome post-COVID o lupus eritematoso.
6.0 - 7.0	54 - 63	Fatiga Extrema / Incapacitante	Imposibilidad de mantener rutinas; reposo obligatorio prolongado.

PUNTO DE CORTE CANÓNICO (KRUPP ET AL.):

- **FSS Media ≥ 4.0 puntos (o Total ≥ 36):** Punto de corte formal que separa la fatiga fisiológica ordinaria de la **fatiga patológicamente invalidante**. En esclerosis múltiple y post-COVID, una media ≥ 5.0 predice reducción severa de la jornada laboral y necesidad de apoyos domiciliarios.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN MANEJO DE FATIGA CRÓNICA

Paso 1: Medición de la Puntuación Media FSS: Calcular (Suma de 9 ítems) / 9.

Paso 2: Si Media < 4.0: Descartar la fatiga como queja médica primaria discapacitante; revisar factores circadianos.

Paso 3: Si Media 4.0 — 4.9 (Fatiga Moderada): Realizar cribado analítico exhaustivo: hemograma, ferritina, función tiroidea (TSH), ionograma, función hepática/renal y vitamina B12/D.

Paso 4: Si Media ≥ 5.0 (Fatiga Severa Patológica):

- **Enfermedades Sistémicas/Neurológicas:** Si hay antecedentes de esclerosis múltiple o COVID, evaluar neurorehabilitación con pautas de conservación de energía (técnica de las 4P: Planificar, Priorizar, Posicionar, Pausar).
- **Descartar Apnea de Sueño:** Si coexiste somnolencia o IMC elevado, aplicar STOP-Bang y derivar a polisomnografía.
- **Despistaje Afectivo:** Evaluar depresión mayor concomitante (la fatiga puede ser el síntoma residual más resistente a antidepresivos ISRS).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN CONDICIÓN POST-COVID-19

Identificación: Mujer de 37 años, enfermera de urgencias, que tras 8 meses de infección aguda por SARS-CoV-2 presenta astenia invalidante, malestar posesfuerzo (PEM) y dificultades para mantener la bipedestación laboral.

Evaluación Inicial FSS: Puntuación Total = **53 / 63**, con una **Media FSS = 5.88 / 7.0** (Fatiga Severa Patológica).

- Ítems destacados: Ítem 2 = 7 (el ejercicio desencadena colapso en 24 h), Ítem 4 = 6 (interferencia motora), Ítem 8 = 7 (síntoma principal), Ítem 9 = 7 (vida paralizada).

Diagnóstico y Manejo: Síndrome de Fatiga Post-COVID (condición post-infecciosa con disautonomía/POTS). Se prescribió evitar el ejercicio extenuante de alta intensidad, pautándose estimulación adaptativa (**pacing**) mediante monitorización de frecuencia cardíaca con pulsera, junto con hidratación y medias de compresión.

Reevaluación a los 5 meses: Siguiendo el protocolo de estimulación adaptativa, la Media FSS descendió a **3.9 / 7.0** (por debajo del umbral de severidad), permitiendo el retorno a tareas administrativas no asistenciales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas en Fatiga:

- **Enfermedad Neoplásica Oculta:** Fatiga inexplicable de inicio reciente con pérdida de peso no voluntaria, sudores nocturnos o adenopatías.
- **Insuficiencia Suprarrenal / Addison:** Astenia extrema con hipotensión ortostática e hiperpigmentación cutánea.

Diagnóstico Diferencial:

- **Fatiga vs. Somnolencia Diurna:** La fatiga es falta de energía; la somnolencia es la tendencia irresistible a quedarse dormido (medir con ESS).
- **Depresión Mayor con Apatía:** En la depresión la persona no tiene interés ni deseo de hacer; en la fatiga pura quiere hacer pero su cuerpo no responde.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Duarte, R. E., Velasco, E., Sánchez-Sosa, J. J., & Reyes-Lagunes, L. I. (2019). Validación psicométrica de la Escala de gravedad de fatiga en médicos residentes mexicanos. *Educación Médica*, 20(1), 28-36. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.11.006>
- Krupp, L. B., LaRocca, N. G., Muir-Nash, J., & Steinberg, A. D. (1989). The fatigue severity scale: Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. *Archives of Neurology*, 46(10), 1121-1123. <https://doi.org/10.1001/archneur.1989.00520460115022>
- Valko, P. O., Bassetti, C. L., Bloch, K. E., Held, U., & Baumann, C. R. (2008). Validation of the fatigue severity scale in a Swiss cohort. *Sleep*, 31(11), 1601-1607.
- Bulbena, A., et al. (2000). Escala de severidad de fatiga en población clínica española. En *Instrumentos de Evaluación en Psiquiatría y Medicina Psicosomática*. Masson.